

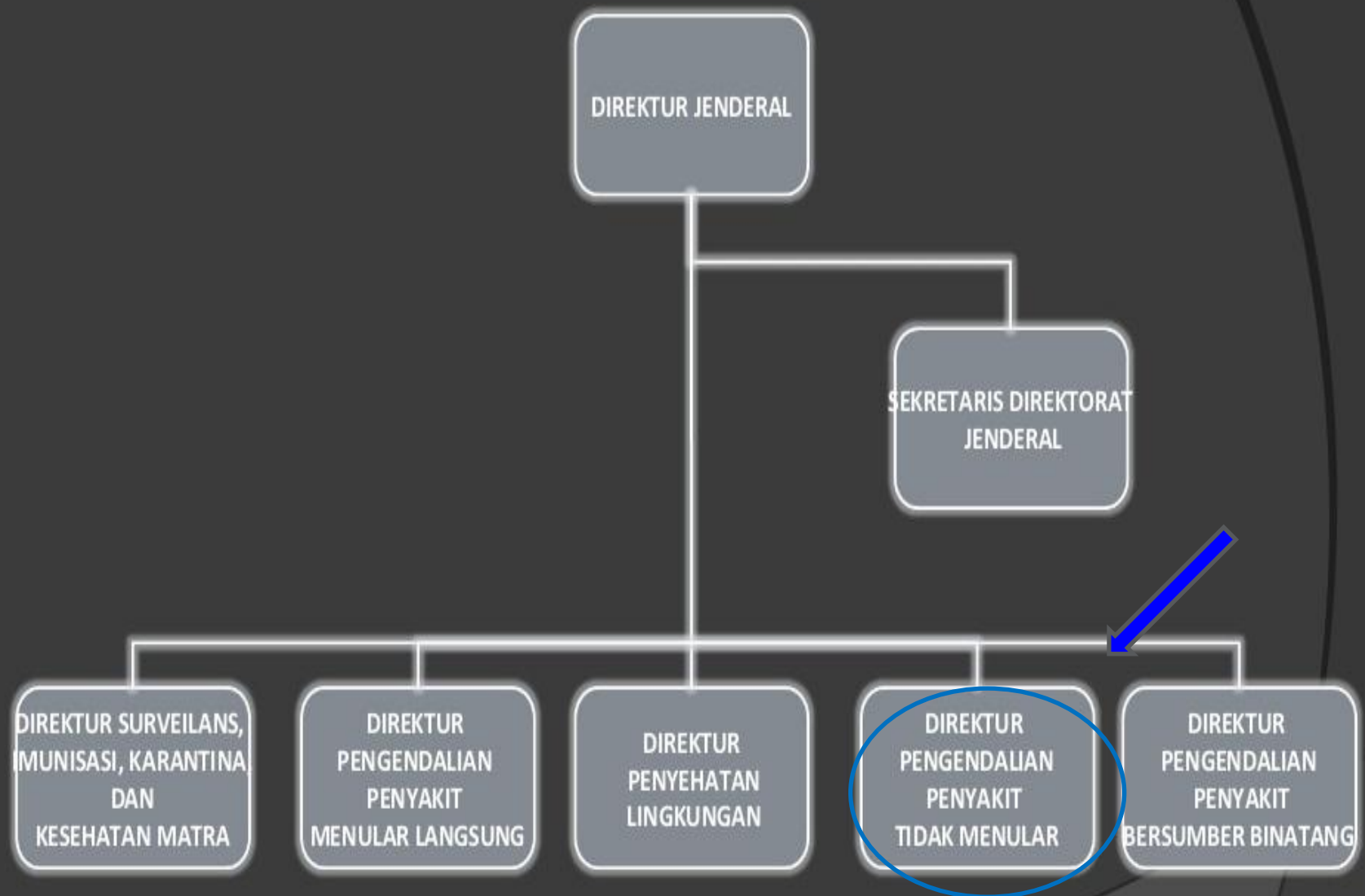


KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

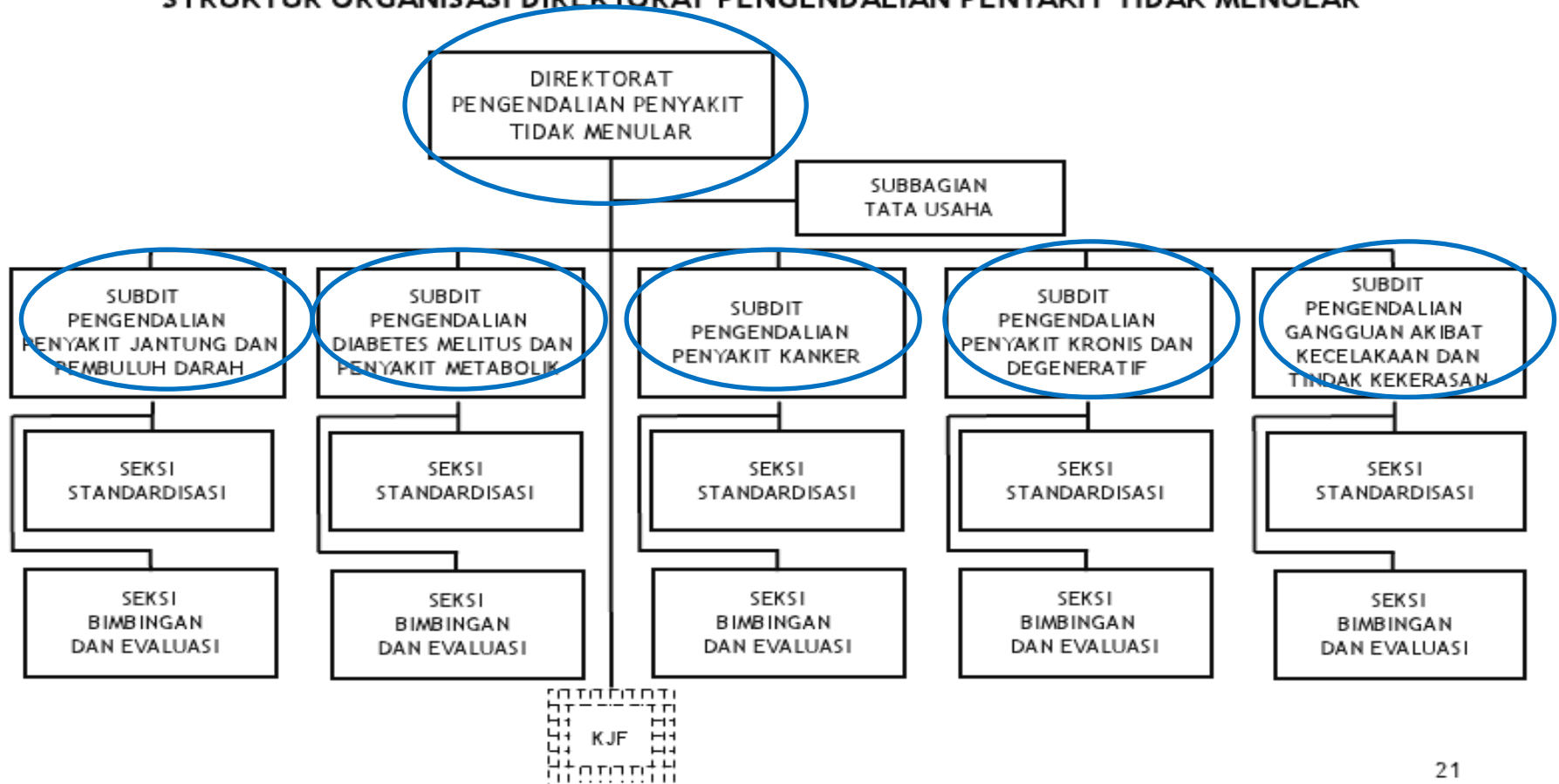
Doby Indrawan, dr., MMRS., FISPH., FISC.M.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN



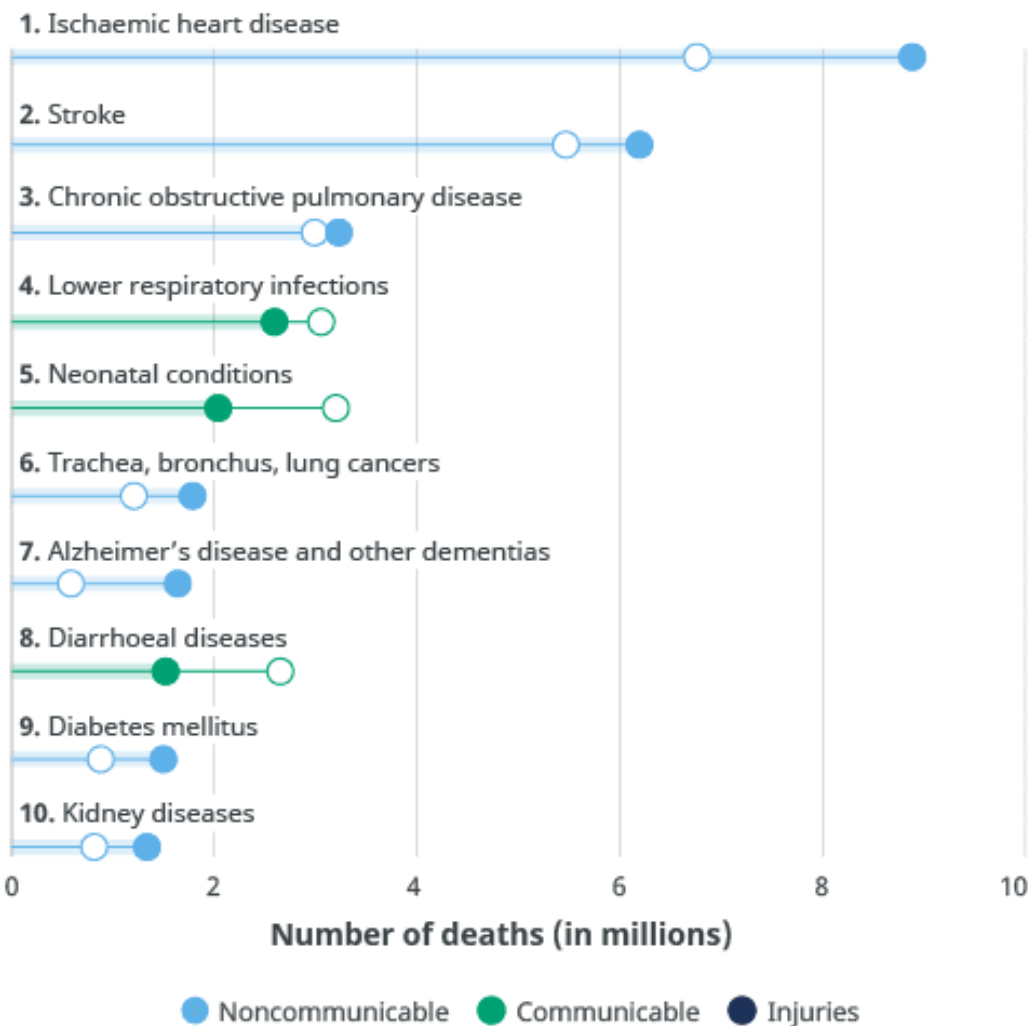
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR



The top 10 causes of death

Leading causes of death globally

○ 2000 ● 2019



Source: WHO Global Health Estimates.

[Health topics](#) ▾[Our work](#) ▾[News](#) ▾[Emergencies](#) ▾[About](#) ▾[Home](#) / [Activities](#) / [noncommunicable-diseases-are-the-no.-1-killers-in-the-who-sea](#)

Noncommunicable diseases are the no. 1 killers in the WHO SEA Region

Cut
down on salt

WHO Catat 66% Kematian di Indonesia Akibat Penyakit Tidak Menular

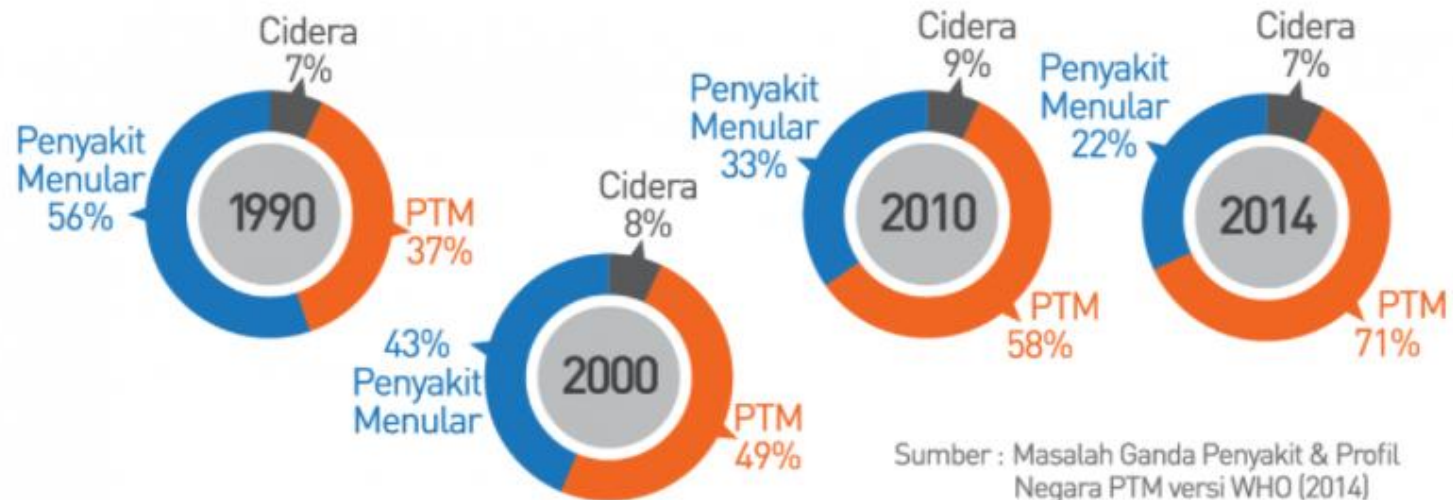
Binti Mufarida

Kamis, 04 Februari 2021 - 13:42 WIB



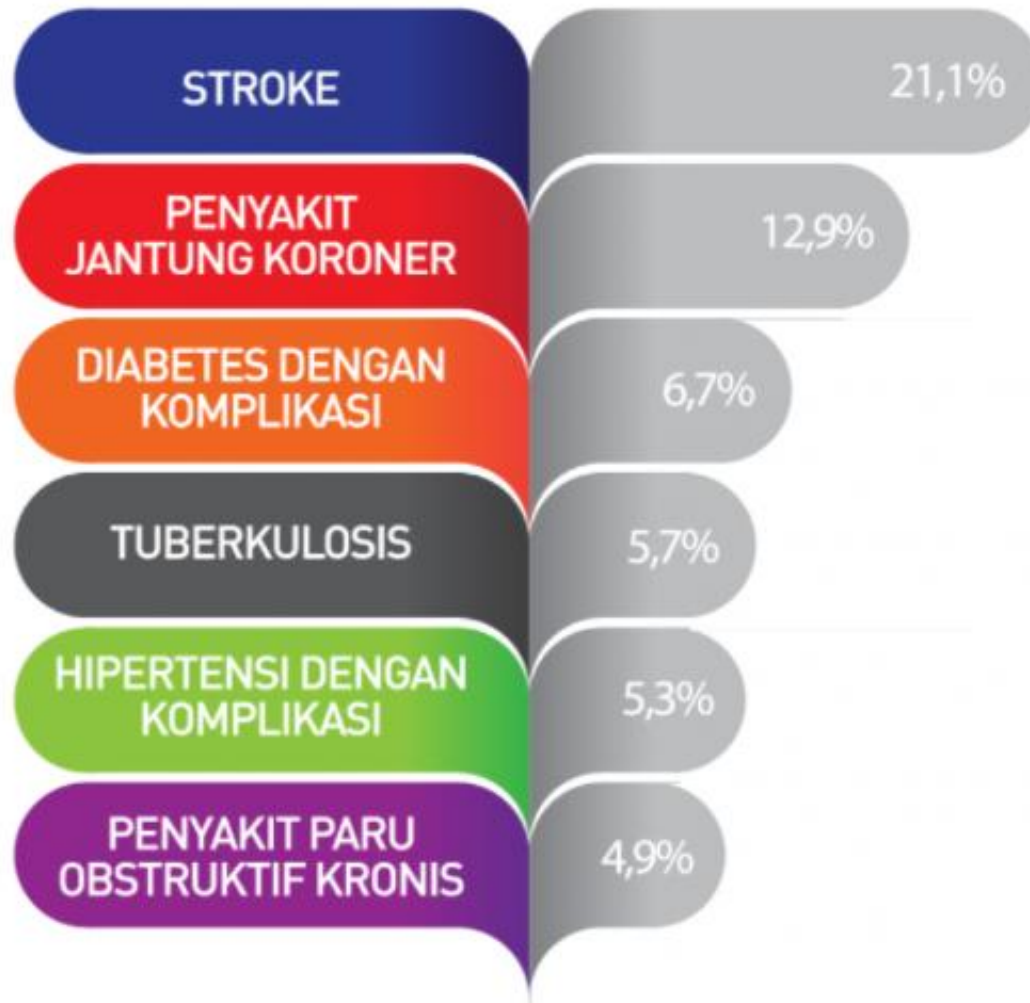
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan data WHO bahwa 66% kematian penduduk Indonesia disebabkan penyakit tidak menular. Foto/dok.SINDOnews

PENYEBAB UTAMA KEMATIAN DI INDONESIA



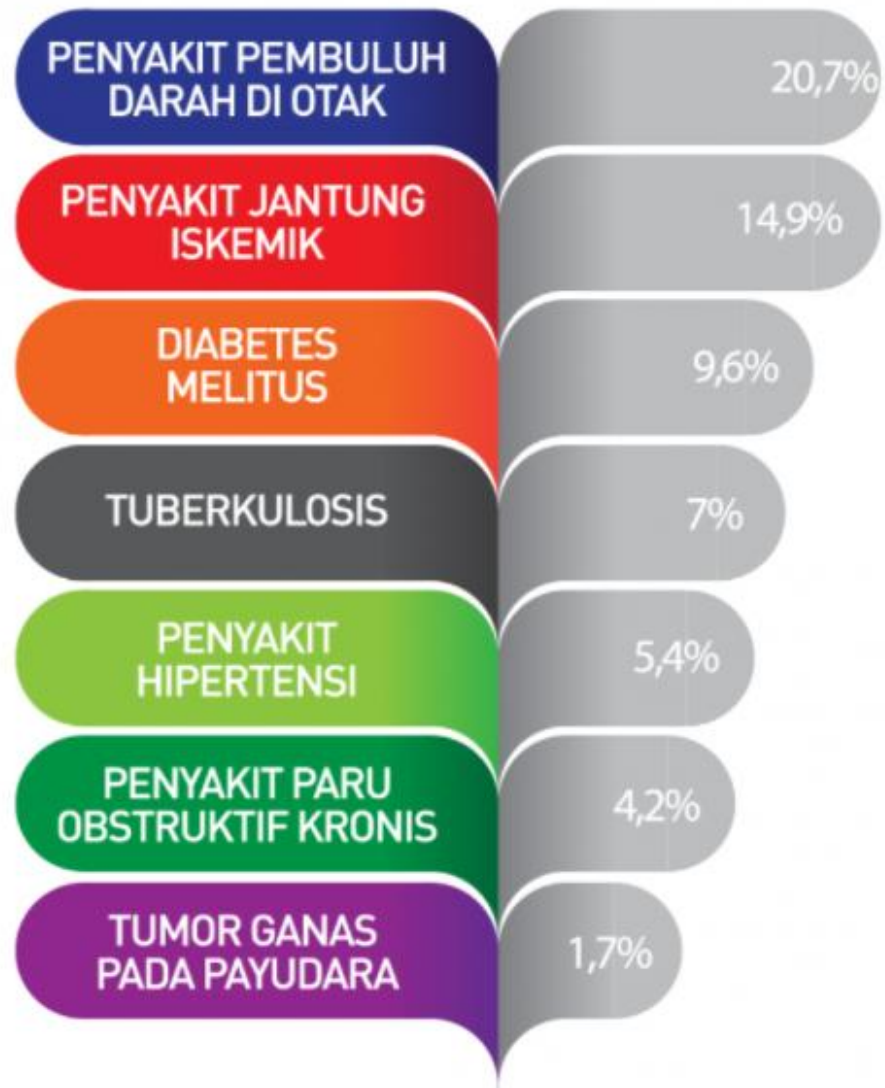
PENYEBAB KEMATIAN UTAMA DI SEGALA UMUR

Sistem registrasi sampel Litbangkes (2014)



PENYEBAB KEMATIAN DI INDONESIA USIA 30-70 TH

(Litbangkes, 2014)

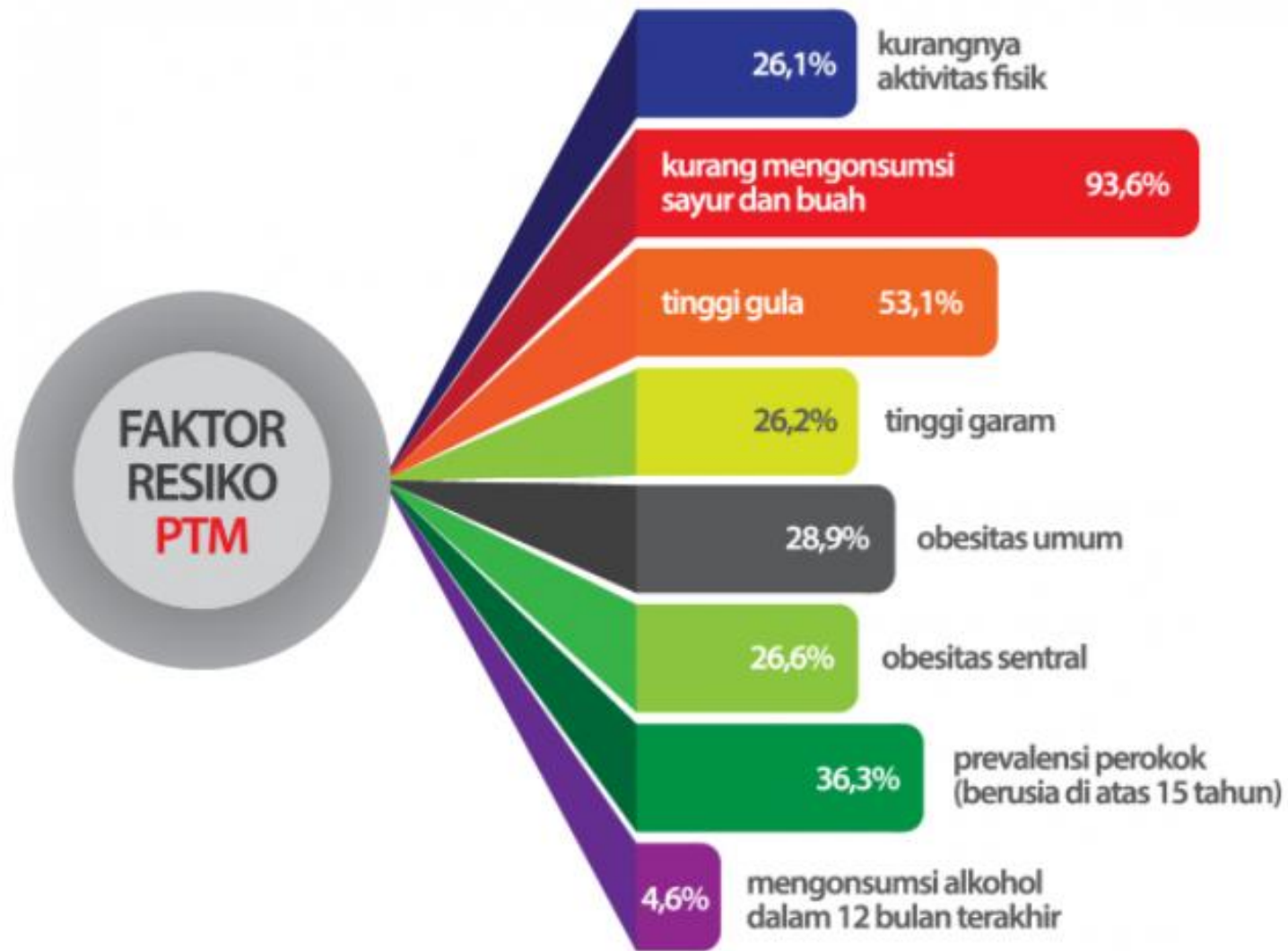


Prevalensi PTM

NO	KASUS PTM	%
1	Hipertensi	31.7
2	Stroke	0.83
3	Penyakit Jantung	7.2
4	Arthritis	30.3
5	Asthma	3.5
6	DM	1.1
7	DM (Urban Population)	5.7
8	Tumor/Cancer	0.43
9	Kecelakaan lalin darat	25.49



Sumber: Riskesdas, 2007



80% perokok ada di negara sedang berkembang

Tembakau sebagai penyebab 5,4 juta kematian di dunia. (Satu kematian setiap 6,5 detik)

Indonesia → 300.000 kematian /tahun akibat rokok

Situasi Tembakau

Prevalensi Perokok Indonesia (%)	Riskesdas	
	2007	2010
Prevalensi merokok (>15 tahun)	33,4	34,7
Perokok Laki-laki (>15 tahun)	65,29	65,9
Perokok Wanita (>15 tahun)	5,06	4,2
Penduduk terpapar asap rokok	84,5	76,1

Global Youth Tobacco Survey: Indonesia, 2007

2009

Pelajar SMP perokok: 20.3 %

30,4 %

Global Adult Tobacco Survey, 2011

34,8 % orang dewasa merokok

PENYAKIT TIDAK MENULAR

Faktor Risiko dan Fase Akhir

Risiko Melekat

- Umur, Sex
- Keturunan dll

Risiko Perilaku

- Merokok
- Diet
- Alkohol
- Aktifitas Fisik
- Stress

Faktor Lingkungan :

Globalisasi, Sosio-ekonomi
Budaya, Modernisasi, Polusi dll

Faktor Risiko / Penyakit Antara

- **Hipertensi**
- **Hiperglikemi**
- **Obesitas**
- **Dislipidemia**
- **Lesi Pra kanker**
- **Bronkhitis/
Emfisema/
Efusi Pleura**

Fase Akhir

- PJK -PD
- Stroke
- Diabetes
- PPOK
- Ginjal Kronik
- Kanker
- Cedera

FAKTOR RISIKO UTAMA PTM



**Penggunaan
tembakau**

**Kebiasaan Diet
Tidak Sehat**

**Kurang
Aktifitas Fisik**

Konsumsi Alkohol

Kardiovaskular

Kanker

Diabetes

PPOK

Osteoporosis

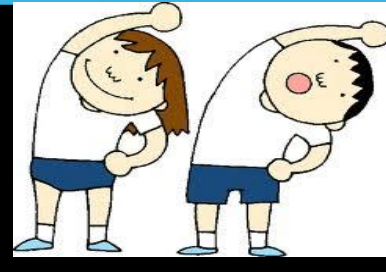
Penyakit Gigi dan Mulut

Gangguan Mental

Cedera & Tisan



Kebijakan dan Strategi Nasional Pengendalian PTM



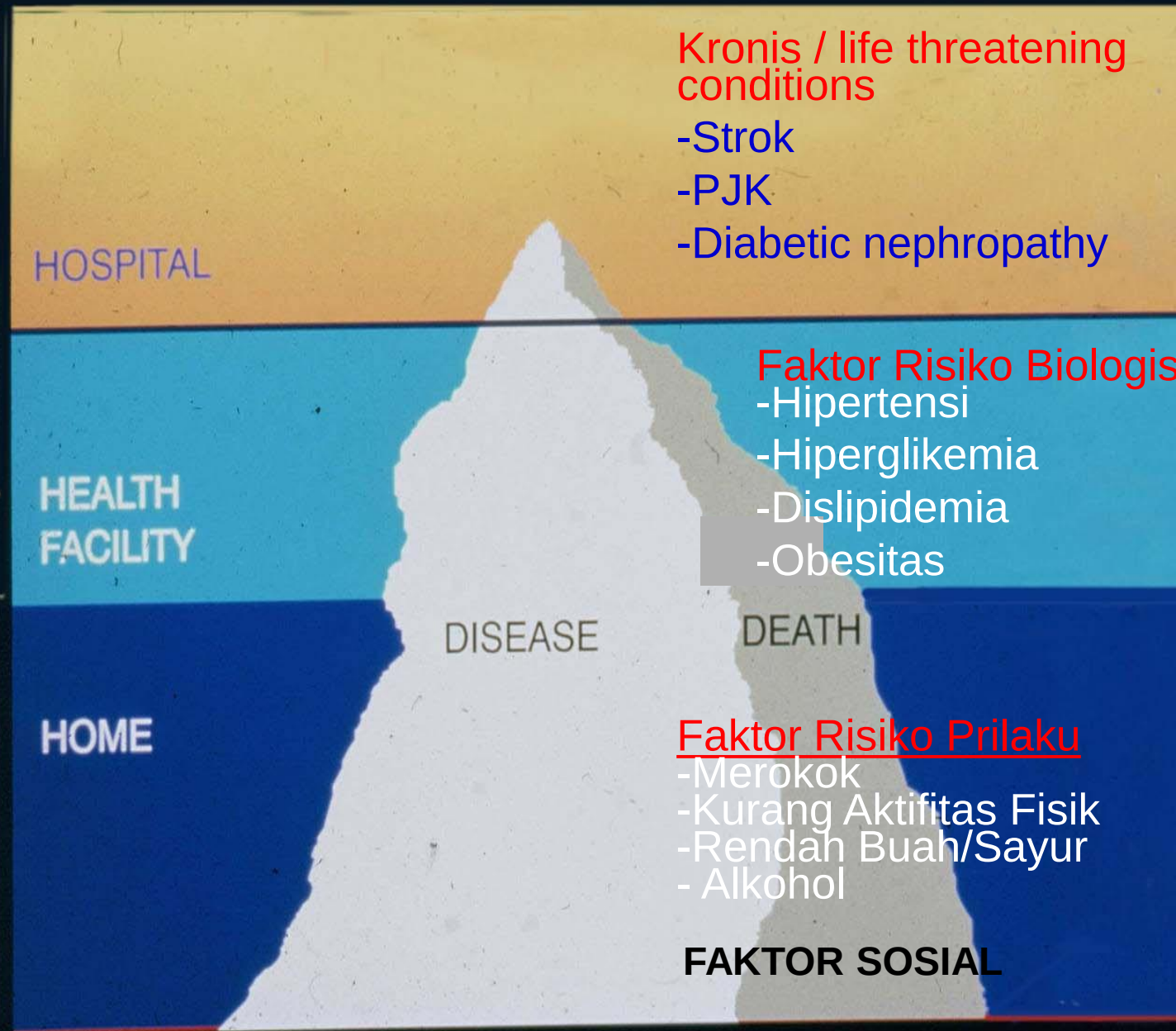
Intervensi

Fenomena Gunung Es PTM

Pencegahan
Kematian prematur
dan Kecacatan
Tatalaksana kasus
strok, PJK,
Komplikasi PTM

Diagnosis Dini
Hipertensi
Hiperglikemia
Dislipidemia
Obesitas

Promosi
Kesehatan &
Pencegahan
Penyakit
Menerapkan
prilaku
sehat pada
individu,
Keluarga & Masy.



TARGET DIT PPTM

SESUAI RENSTRA KEMENKES 2010 -2014

NO	OUTCOME	INDIKATOR	2010	2014
1	1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat PTM 2. Meningkatnya Pencegahan & Penanggulangang an PTM	Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan tanpa Rokok	40	100
2		Persentase propinsi yg melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE, Deteksi Dini, KIE, Talalaksana)	50	100
3		Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE, deteksi dini, KIE dan Tatalaksana)	10	30
4		Persentase kab/kota yang melaksanakan <i>Inspeksi Visual Asam Acetat (IVA)</i> dan <i>Clinical Breath Examination (CBE)</i>	5	25
5		Persentase kab/kota yang mempunyai peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/ Instruksi/ SK/ Peraturan Walikota/Bupati/ Perda) tentang pecegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan	10	30

TARGET GLOBAL DIREKTORAT PPTM

2015 - 2025

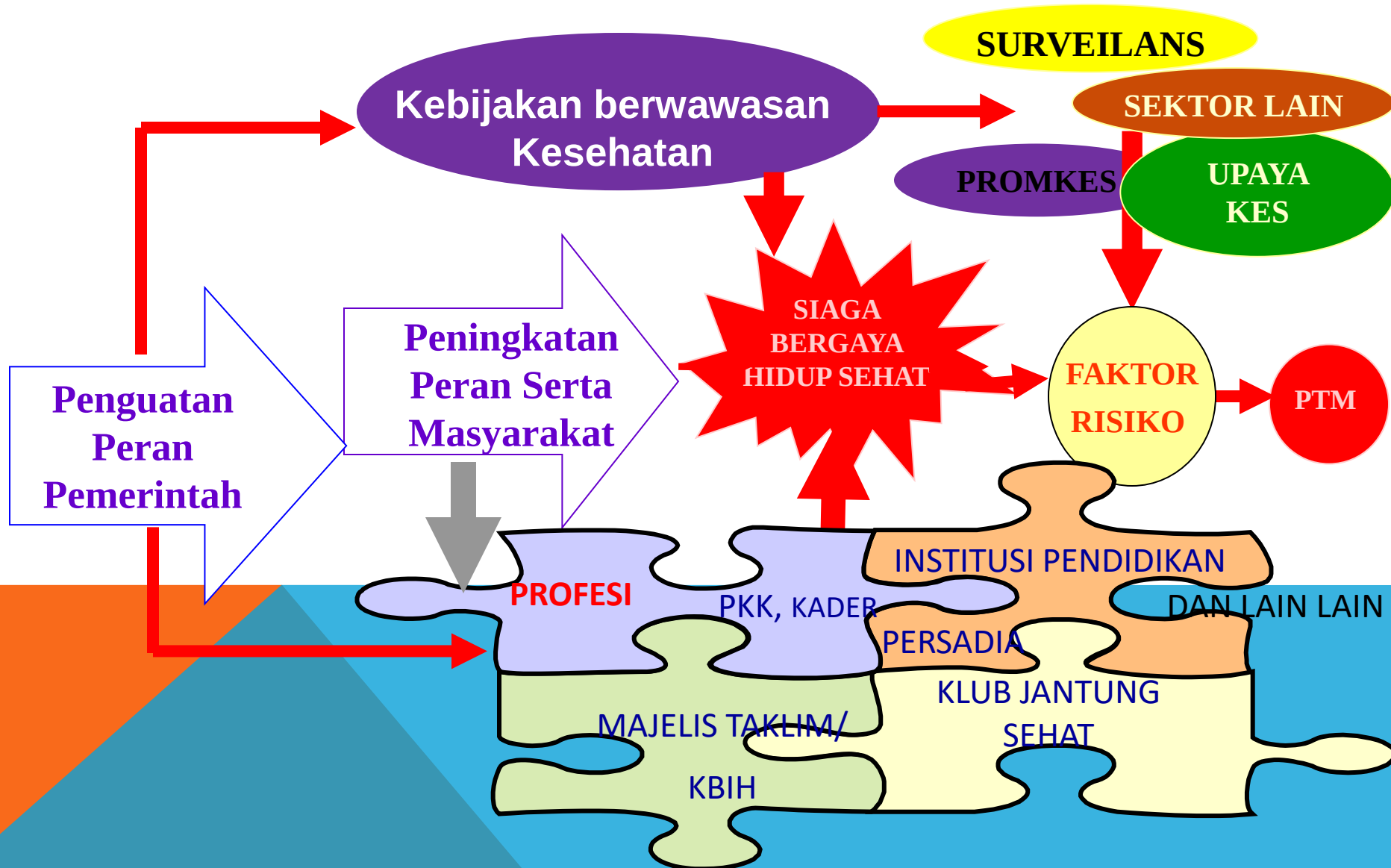
NO	TARGET
1	Penurunan sekitar 25% seluruh kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, kanker, Diabetes, penyakit paru kronik.
2	Penurunan sekitar 10% dari penggunaan alkohol yang berbahaya
3	Penurunan 10% angka prevalensi aktivitas fisik yang tidak memadai
4	Penurunan secara relatif 30% pada rata-rata populasi dalam asupan garam/sodium
5	Penurunan 10% prevalensi penggunaan tembakau pada umur 15 tahun ke atas
6	Penurunan angka prevalensi tekanan darah tinggi relatif sebesar 25%
7	Memberhentikan peningkatan diabetes dan kegemukan
8	50% orang mudah mendapatkan akses mendapat terapi obat dan konseling meliputi kontrol glikemik untuk mencegah serangan jantung dan stroke
9	80% populasi mendapatkan pelayanan teknologi dasar dan pengobatan utama yang diperlukan dalam perawatan NCDs

TARGET PROGRAM

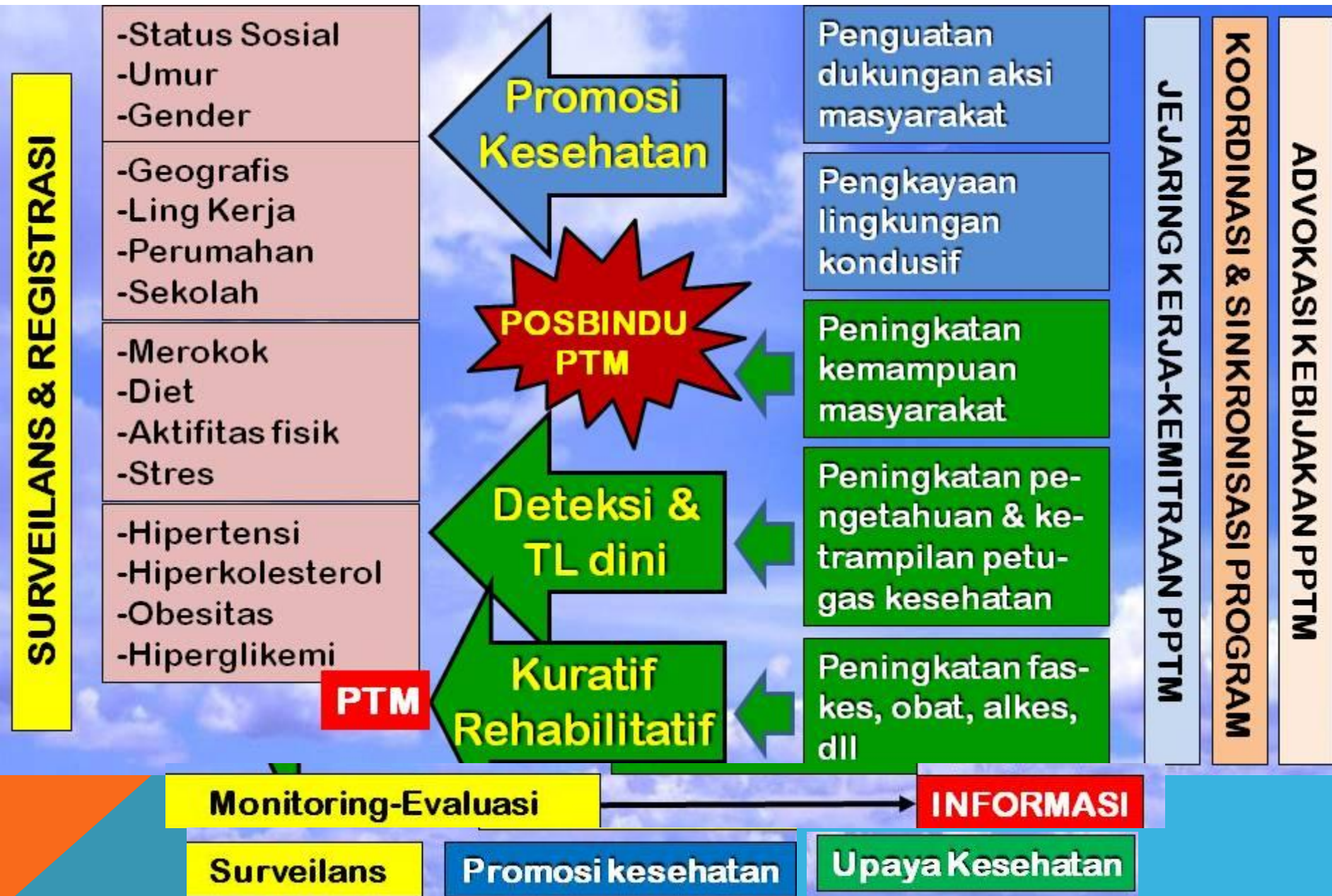


PROGRAM	TARGET
Terbentuknya Pokja PPTM dan KTR	Di 50% Kab/Kot di setiap Prov
Peningkatan deteksi dini FR di masyarakat	Di 25.000 desa di 50% Kab/ Kot di setiap Prov selenggarakan Posbindu PTM (2014)
Peningkatan kapasitas SDM	Pembentukan Tim Pengendalian PTM di setiap Prov
Peningkatan akses pelayanan PTM	Di 50% Kab/Kot di setiap Prov (2014)
Pengembangan sistem surveilans PTM	Di 50% Kab/Kot di setiap Prov (2014)

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PPTM



STRATEGI KOMPREHENSIF PENGENDALIAN PTM



P2PTM KEMENKES STRATEGI 4 BY 4



KEBIJAKAN (1)



Mengembangkan & perkuat program pengendalian faktor risiko PTM



Meningkatkan advokasi & diseminasi program pengendalian Faktor Risiko PTM



Mengembangkan & perkuat monitoring deteksi dini FR, TL Dini, Tatalaksana kasus & respons cepat kegawat-daruratan PTM



Mengembangkan & perkuat manajemen, ekuitas dan kualitas peralatan untuk deteksi dini FR PTM

KEBIJAKAN (2)



Meningkatkan profesionalisme SDM dalam pengendalian FR PTM



Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans epidemiologi FR dan sistem informasi PTM



Meningkatkan pemantauan program pengendalian FR PTM



Mengembangkan dan memperkuat jejaring dan kemitraan pengendalian FR PTM

TIGA STRATEGI UTAMA

SURVEILANS PTM

- Berbasis survey PTM berkala (Riskesdas, Susenas, SDKI, survey kematian, Survey Pasar dll)
- Berbasis Registri PTM (Hospital based)
- Berbasis Fasilitas Kesehatan (SIMPUS, SIRS, Laboratorium)
- Berbasis Litbangkes
- Evidence Based → Advokasi → Perencanaan → Pelaksanaan

PROMOSI KESEHATAN

- Promkes dan perlindungan ‘population at risk’ PTM → KTR, Kota Layak Anak, Keselamatan di Jalan, dll
- Regulasi Kesehatan → KTR, PERMENKES Garam-gula-lemak
- Health in All Policy → Advokasi Pemda, Lintas Sektor, DPRD, dan Industri/Swasta(CSR)
- Penguatan Jejaring kerja-Kemitraan → **“Triple ACs”**

BINA UPAYA KESEHATAN

- Deteksi dan Tindak Lanjut Dini di Masyarakat
- **Self Care Faktor Risiko PTM**
- **Respon cepat kegawatdaruratan PTM**
- **Yandas PTM terpadu di Puskesmas/Dokter Keluarga**
- **PAL, IVA + CBE**
- **Yan Rujukan PTM di Rumah Sakit**

CLEARCHANNEL

PROGRAM PENGENDALIAN PTM



PROGRAM PENGENDALIAN PTM TERINTEGRASI

Populasi Sehat

Promosi Kesehatan

- Lingkungan Kondusif: KTR, Sarana OR, dll
- Gaya Hidup Sehat: Tdk Merokok, Cukup Aktivitas Fisik, dan Diet yg Sehat
- Deteksi Dini dan Tinjau Dini/ Konseling FR
- RUJUKAN

-Posbindu PTM
-Masyarakat

Pop Berisiko

Pengendalian FR terintegrasi

- Penatalaksanaan Kasus FR yg adekuat :
 - Hipertensi,
 - Dislipidemia,
 - Hiperglikemia,
 - Merokok,
 - Obesitas,
 - Sadari
- RUJUKAN

Puskes Sentinel
Dokter Keluarga

Populasi Sakit

Pengendalian PTM & Komplikasi

- Penatalaksanaan Kasus PTM :
 - UGD
 - Diagnosis
 - Rawat Jalan
 - Rawat inap
 - Tindakan Medik (Operasi, amputasi, dialisis)
- RUJUKAN

Rumah
Sakit

- Pencegahan Komplikasi dan rehabilitasi:
 - Rehabilitasi Medik
 - Home Care
 - Monitoring dan
 - Pengendalian FR
 - Paliatif
 - Senam PTM
 - Rehabilitasi survival stroke (neuro restorasi)
 - Paska oprs jantung
- RUJUKAN

-Puskes Sentinel
-Dokter keluarga
-Masyarakat

**Surveilans FR PTM di Masyarakat
SP2TP**

Surveilans/Registri PTM - SIRS

PELAYANAN PTM

Di MASYARAKAT

Wawancara dan pengukuran FR melalui kegiatan Posbindu PTM dan Perilaku CERDIK

Di PUSKESMAS

Pemeriksaan FR PTM rutin pada semua pengunjung Puskesmas usia ≥ 18 thn

Kegiatan di PUSKESMAS

Pencegahan primer

Promkes: meningkatkan kesadaran & pengetahuan masyarakat

Pencegahan Sekunder

Deteksi dini dan Pengobatan dini sehingga penyakit tidak semakin parah

Pencegahan Tersier

TL dini dan tatalaksana kasus termasuk respons cepat → mencegah kecacatan dan kematian dini serta komplikasi

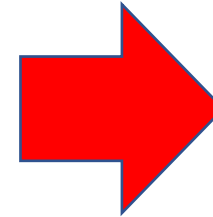
STRATEGI P2PTM

Advokasi,
kerjasama,
bimbingan dan
manajemen
PTM

Promosi,
pencegahan, dan
pengurangan
faktor risiko PTM
melalui
pemberdayaan
masyarakat

Penguatan
kapasitas dan
kompetensi
layanan
kesehatan, serta
kolaborasi sektor
swasta dan
profesional

Penguatan
surveilans,
pengawasan
dan riset PTM



**Pos
Pembinaan
Terpadu
(Posbindu)
PTM**



Deteksi Dini

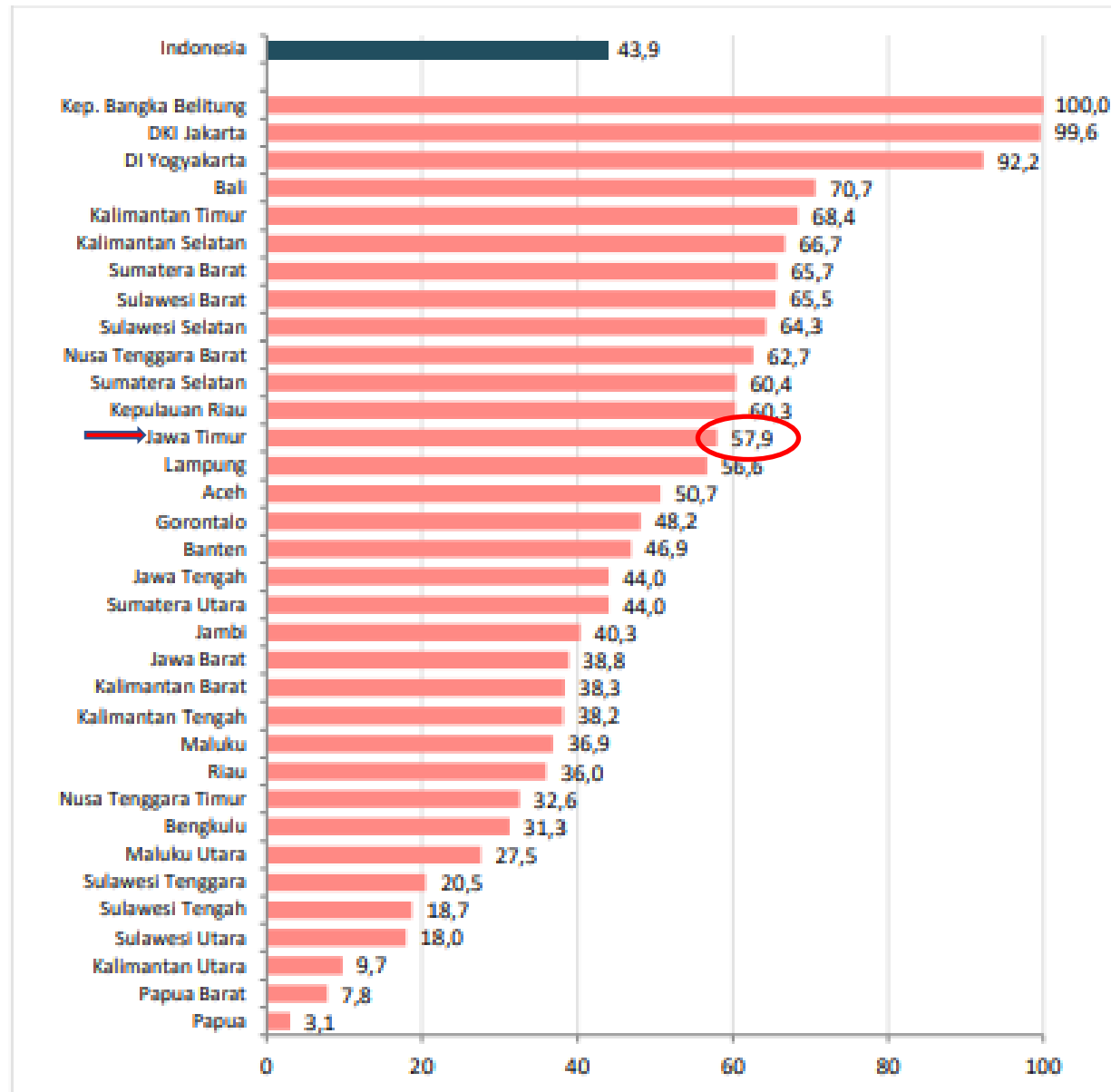
JUMLAH POSBINDU PTM PER DESEMBER 2017

33.679 (24.9 %) POSBINDU



Sumber : Pengawasan Posbindu PTM

**PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM
MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2018**



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019

DIMANA?

**RUMAH
TANGGA**

SEKOLAH

TEMPAT KERJA

TEMPAT UMUM

POSBINDU PTM

**Apa
Kegiatannya?**

**Deteksi dini & konseling,
melalui monitoring faktor risiko
PTM terintegrasi yg dilakukan
secara rutin dan periodik**

Monitoring

- Obesitas
- Hipertensi
- Hiperglikemi
- Hiperkolesterol
- Pem. Klinis Payudara
- Faktor lain
- KIE
- **Aktifitas Fisik**
- Sarasehan

Konseling

- Diet
- Stop Merokok
- Stress
- Self Care

KETAHANAN INFORMASI

Ketahanan Informasi Nasional

Puskesmas Turen Kabupaten Malang, Cipta Inovasi Posbindu Mobile

Jumat, 18 Oktober 2019 - 20:00 | 163.27k



TIMES INDONESIA

Kegiatan Posbindu PTM di Desa Sananarejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang tanggal 27 September 2019. (FOTO: AJP TIMES Indonesia)

Melalui Posbindu PTM, Dinkes Kota Malang Ajak Masyarakat Cegah Penyakit Tidak Menular

Kesehatan

Dec 03, 2018 11:3



04 Oktober 2018

Penguatan Surveilans dan Sistem Informasi PTM di Kota Batu





Kegiatan wawancara bersama Perangkat Desa & Kader Mulyoagung,
Kec. Dau, Kab. Malang (Dok.28.10.2020)

“Kami ga pernah dilatih oleh perawat Puskesmas, cuma disuruh menyiapkan 5 meja dan nanti bantu-bantu ngukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan dicatat di lembar laporan gitu kata perawat Puskesmas”. (Kader posyandu lansia Karang Werda).

“Ngapunten dokter Doby, sebelum pandemi di akhir tahun lalu sekitar bulan Oktober pernah ada kegiatan posbindu tapi cuma sekali saja, setelah itu tidak pernah dilakukan lagi sampai sekarang”. (Kades Mulyoagung).

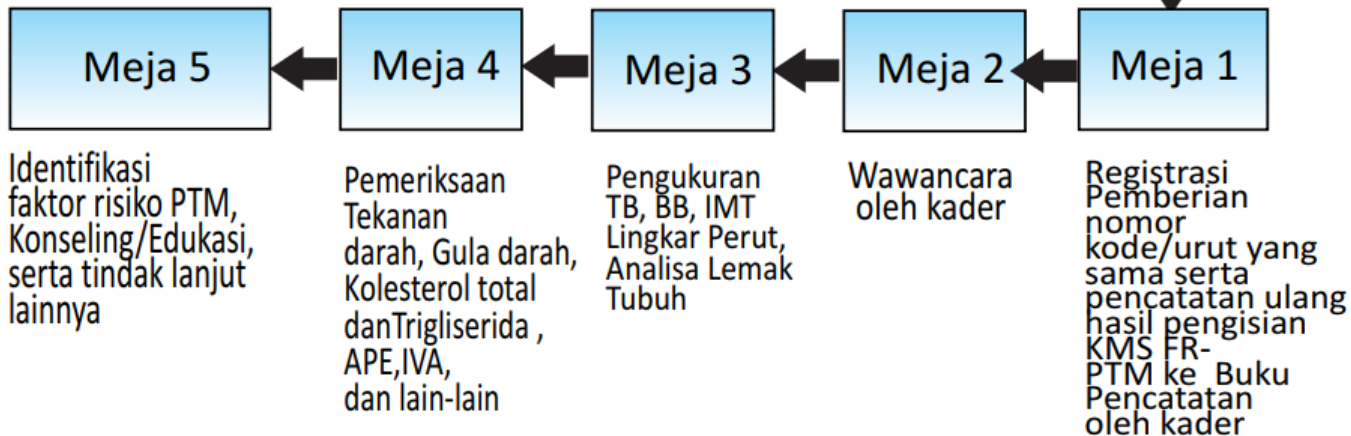
“Pihak Puskesmas menghubungi saya, dokter Doby. Mereka meminta jika ada kegiatan Posbindu lagi dimohon catatan laporan diserahkan ke Puskesmas namun kader tidak bersedia karena jauh dari Puskesmas dan pada repot, begitu dokter”. (Sekdes Mulyoagung).

Proses Kegiatan Posbindu PTM

Kegiatan Sebelum Pemeriksaan
(Senam bersama, bersepeda, ceramah agama, demo makanan sehat, dll)
bekerjasama dengan yayasan, LSM, Majelis Ta'lim, Gereja setempat, dll)

Sambil menunggu giliran pemeriksaan kader melakukan **penyuluhan kelompok** serta **memberikan lembar wawancara untuk diisi peserta**

Pemeriksaan
(satu per satu)



Sumber : Petunjuk Teknis Kegiatan Posbindu PTM



“Saya bangga...
sebagai **Kader Posyandu”**
karena dapat membantu kesehatan anak di desaku



Form - 1

BUKU REGISTER/ PENCATATAN POSBINDU

POSBINDU : KARANG WERDA TAHUN : 2020

DESA MULYOAGUNG, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

No	Nama Lengkap	KTP	Umur	L/ P	Agama	Alamat	Hp	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Gol. Darah

Form - 2

BUKU REGISTER/ PENCATATAN POSBINDU

POSBINDU : KARANG WERDA 2020

DESA MULYOAGUNG, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

No	Nama Lengkap	Riwayat PTM Keluarga	Riwayat PTM Sendiri	Merokok	Kurang Aktifitas Fisik	Kurang Sayur Buah	Konsumsi Alkohol	Stress

Form - 3

BUKU REGISTER/ PENCATATAN POSBINDU

POSBINDU : KARANG WERDA TAHUN : 2020

DESA MULYOAGUNG, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG

No	Nama Lengkap	Berat Badan	Tinggi Badan	Indeks Massa Tubuh	Lingkar Perut	Tekanan Darah	Gula Darah Sewaktu	Kolesterol Total



TANTANGAN

**MASALAH
PTM**

**Terus meningkat dan
Jadi masalah di Prov/Kab/Kota**

**Spektrum masalah amat luas
Tapi punya faktor risiko bersama**

PERILAKU dan GAYA HIDUP

**Pengendalian
yang efektif dan efisien**

**FOKUS:
faktor risiko secara terintegrasi**

**PERLU: Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi yang Sinergi Linsek
/Linpro di: Prov/Kab/Kota**

DIET

ROKOK

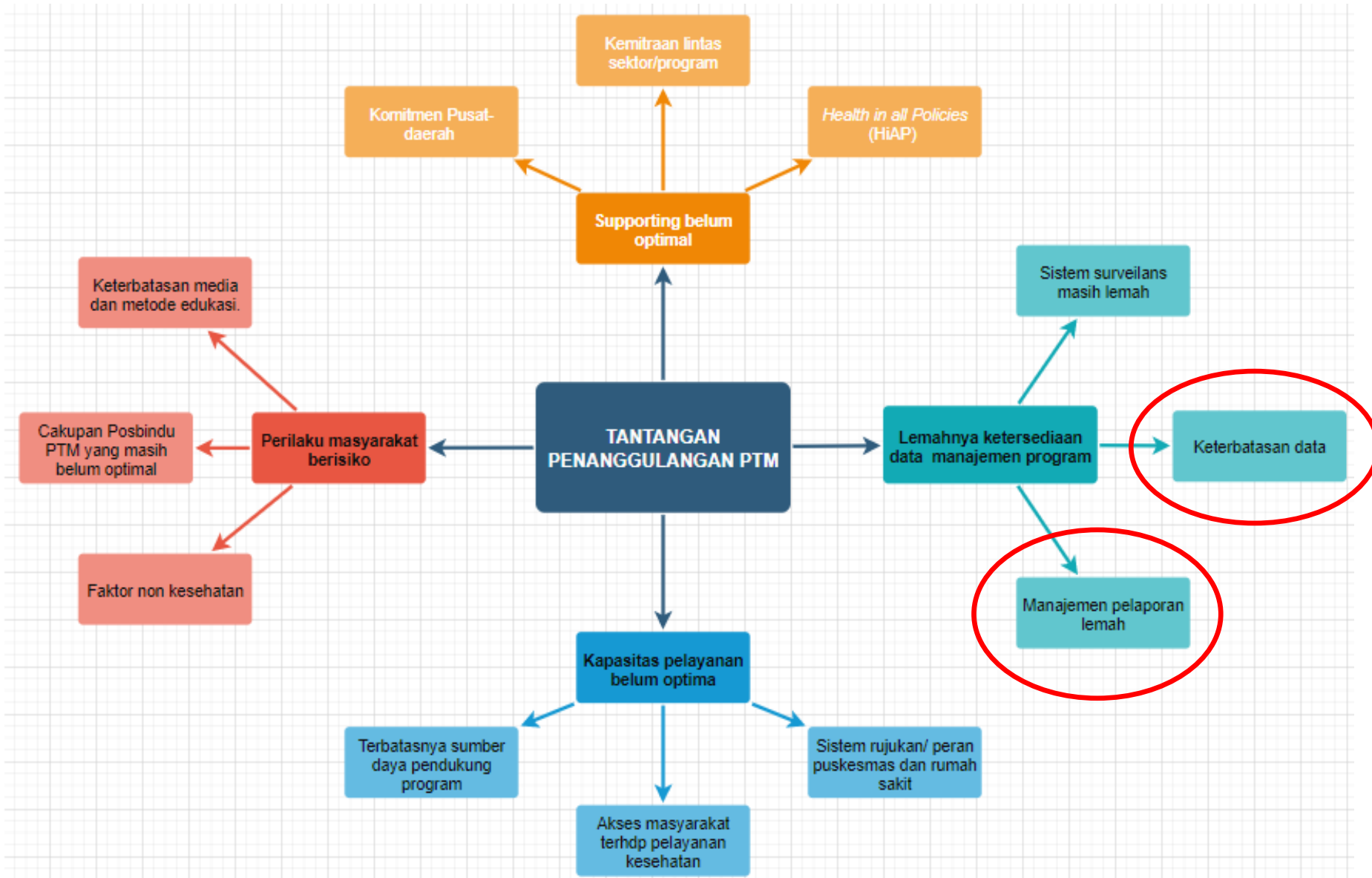
ALKOHOL

**Kurang
aktivitas fisik**

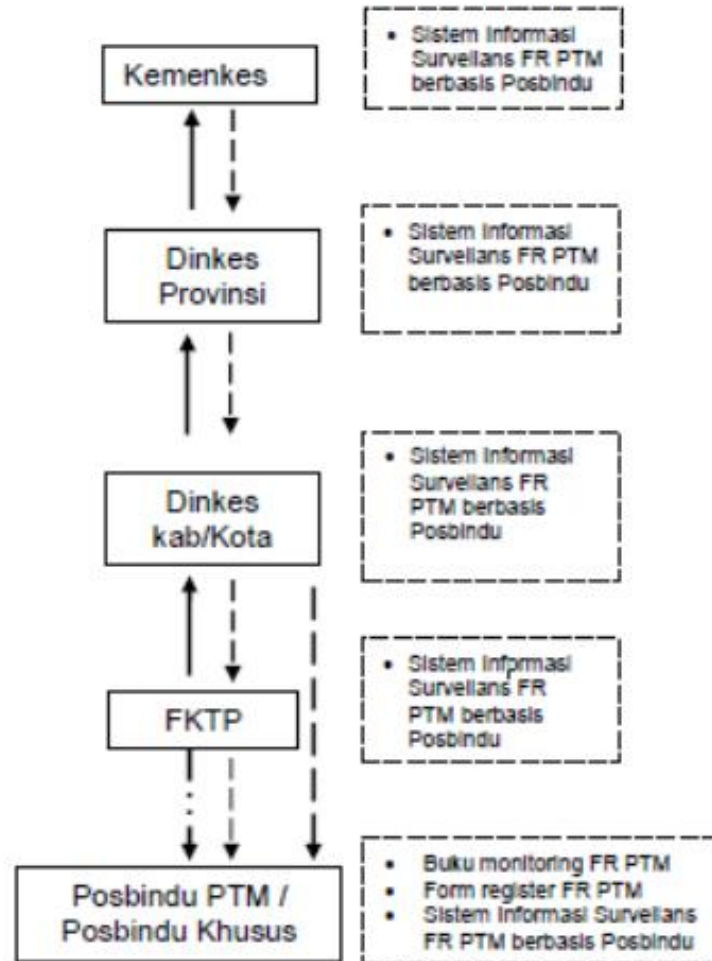


TANTANGAN PENANGGULANGAN PTM

(Permenkes No. 5/2017 Ttg Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PTM 2015-2019)



ALUR SISTEM PELAPORAN KEGIATAN POSBINDU



Keterangan:

—————> = Melaporkan

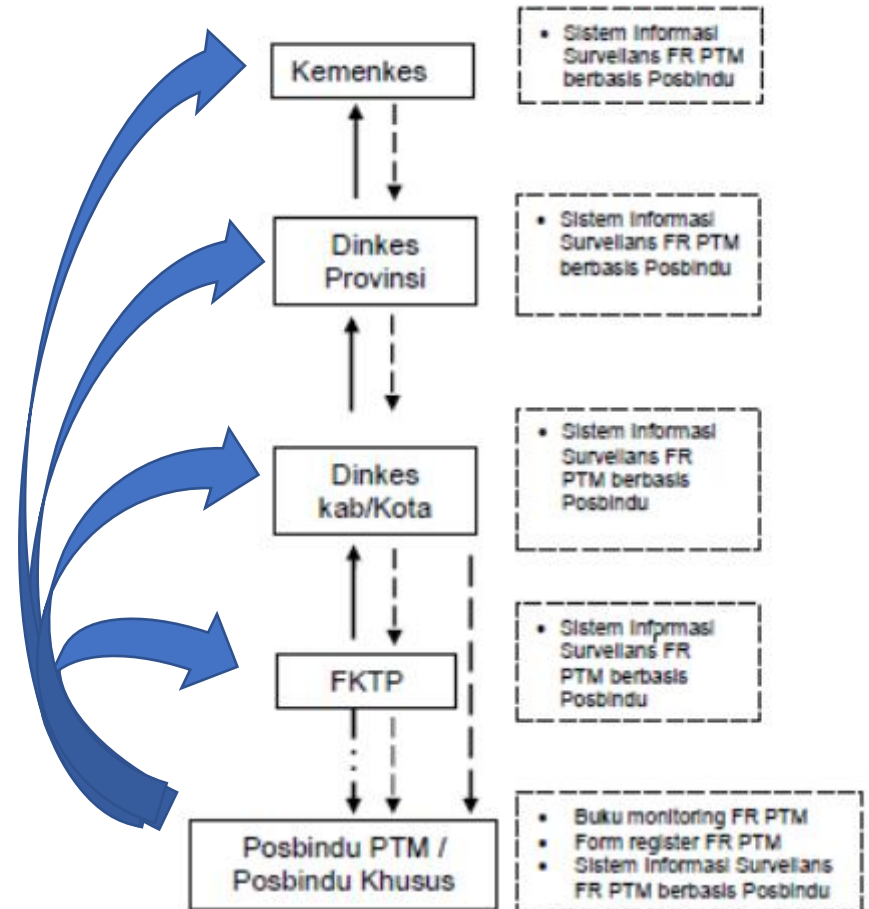
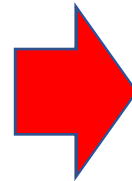
- - - - -> = Umpan balik

- . . . - . . .> = Mengambil data

Sumber : Modul Surveilans Faktor
Risiko Berbasis Posbindu PTM

ALUR SISTEM PELAPORAN KEGIATAN POSBINDU

PENGAMBANGAN MODEL SISTIM PELAPORAN



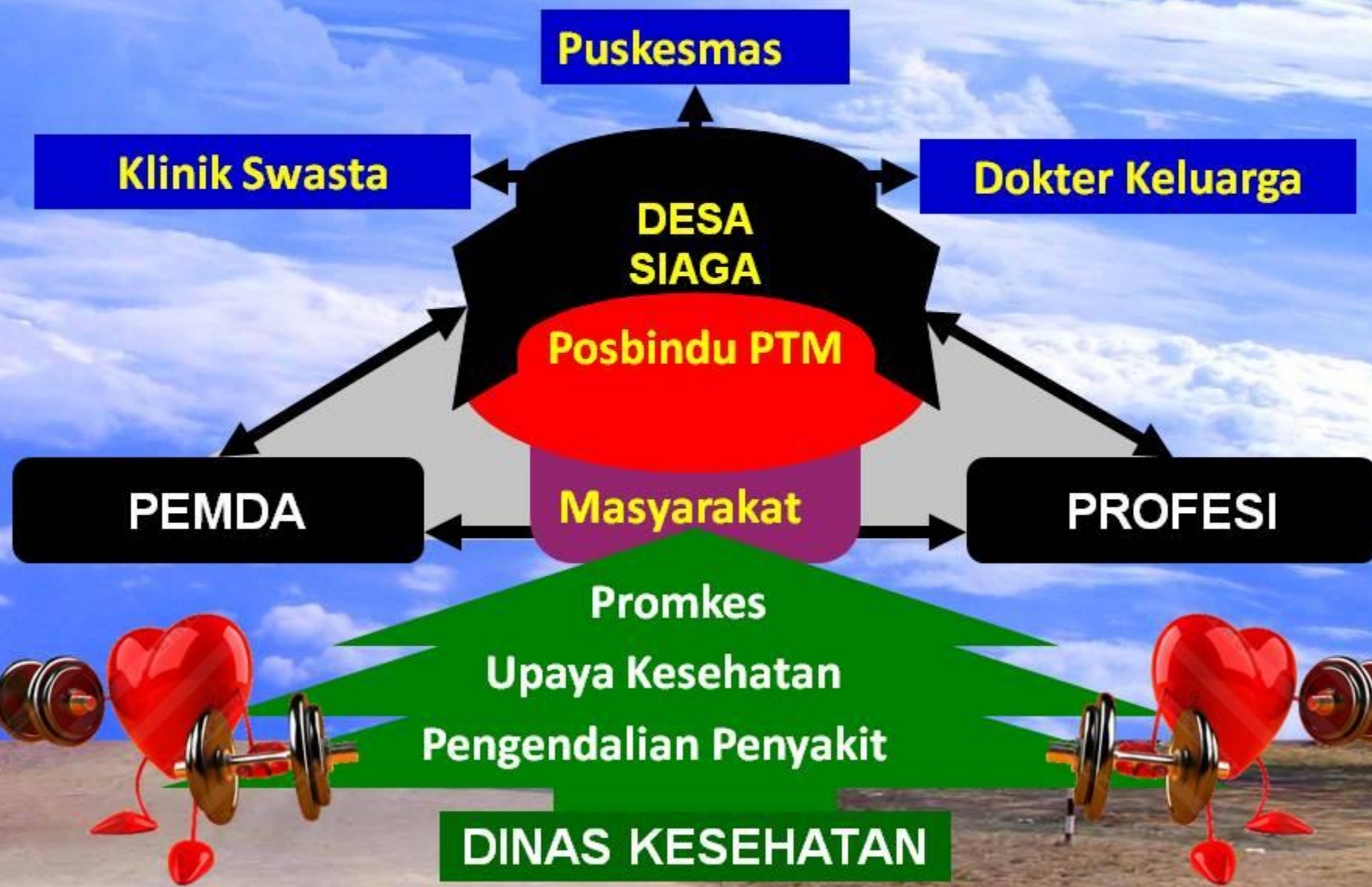
Keterangan:

- = Melaporkan
- - - - -→ = Umpan balik
- . . . - .→ = Mengambil data

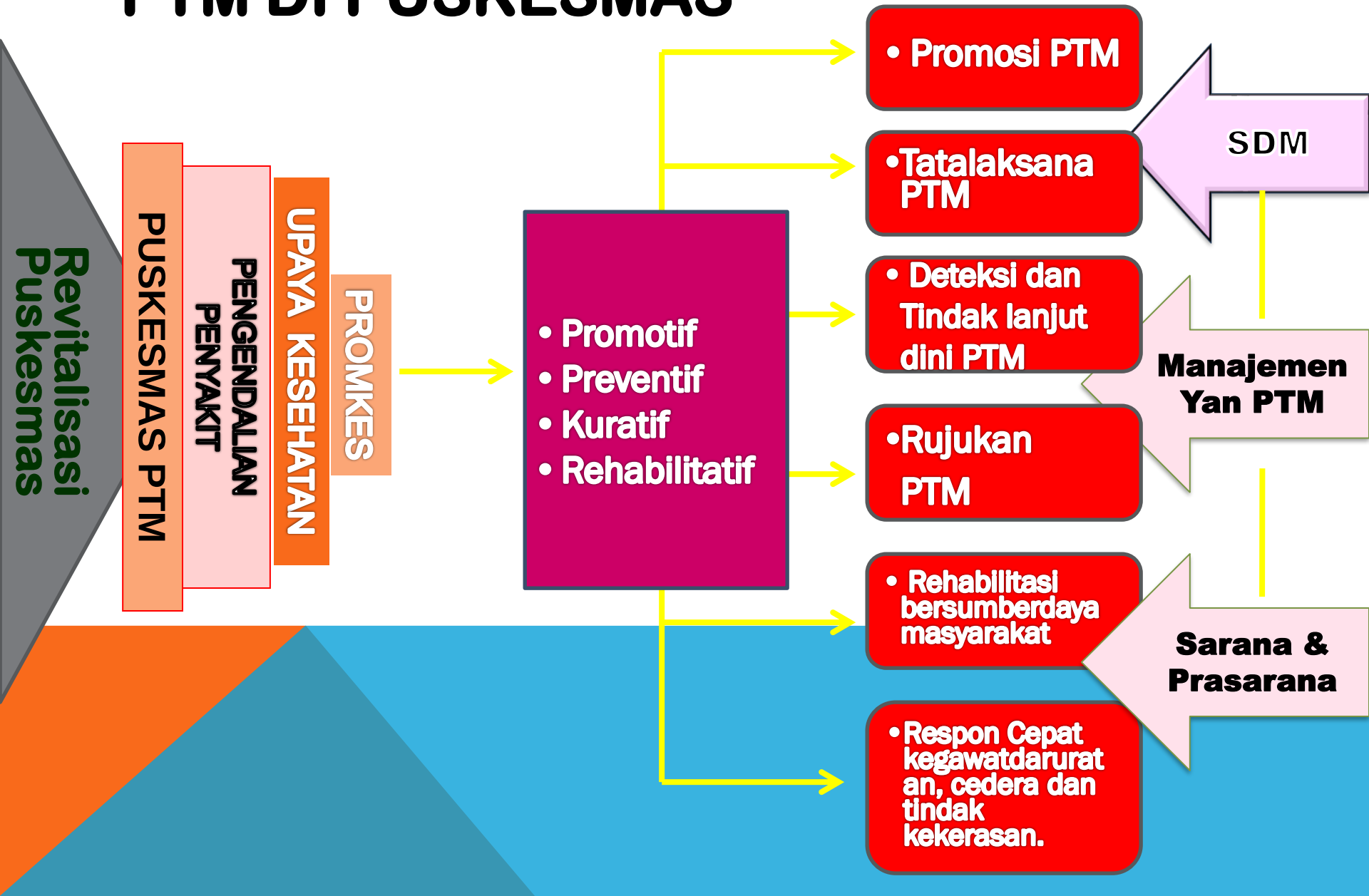
Sumber : Modul Surveilans Faktor Risiko
Berbasis Posbindu PTM

Program Monitoring & Deteksi Dini FR-PTM

Pos Kesehatan Terpadu Untuk PTM (Posbindu PTM)



PENGEMBANGAN PELAYANAN PTM DI PUSKESMAS



Kebijakan Pengendalian Rokok Indonesia

UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan

Pasal-pasal di bawah mengatur tentang:

Pasal 113

**Pengamanan
penggunaan bahan
yang mengandung
zat adiktif**

Pasal 114

Peringatan Kesehatan

Pasal 115

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 116

**Ketentuan Lebih Lanjut
Melalui Penetapan
Peraturan Pemerintah**

Pasal 199

**Ketentuan
Pidana**





Kebijakan Pengendalian Rokok (Kawasan Tanpa Rokok)



- **UU No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan, ps 115 tentang KTR, ps 116 Pemda wajib menetapkan KTR**
- **UU No. 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit → RS wajib KTR**
- **Peraturan Bersama Menkes – Mendagri No. 188/Menkes/PB/I/2011 ttg Pedoman Pelaksanaan KTR**
- **Fatwa MUI : Rokok “Haram” untuk anak-anak usia < 18 tahun, ibu hamil, dan di tempat umum**
- **Fatwa PP Muhammadiyah, Rokok “Haram”**
- **SKB Mendagri – Menkes No. 34 th 2005 & No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 ttg Pedoman Penyelenggaraan Kota Sehat**

**PERATURAN PEMERINTAH
NO. 109 TAHUN 2012
TENTANG PENGAMANAN
BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF BERUPA PRODUK
TEMBAKAU BAGI
KESEHATAN**

TUJUAN PP NO. 109 TAHUN 2012

1

Melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan

2

Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan

3

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok

4

Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain

KAWASAN TANPA ROKOK



Pemda
menetapkan
KTR di
daerahnya

KTR diberlakukan pada:

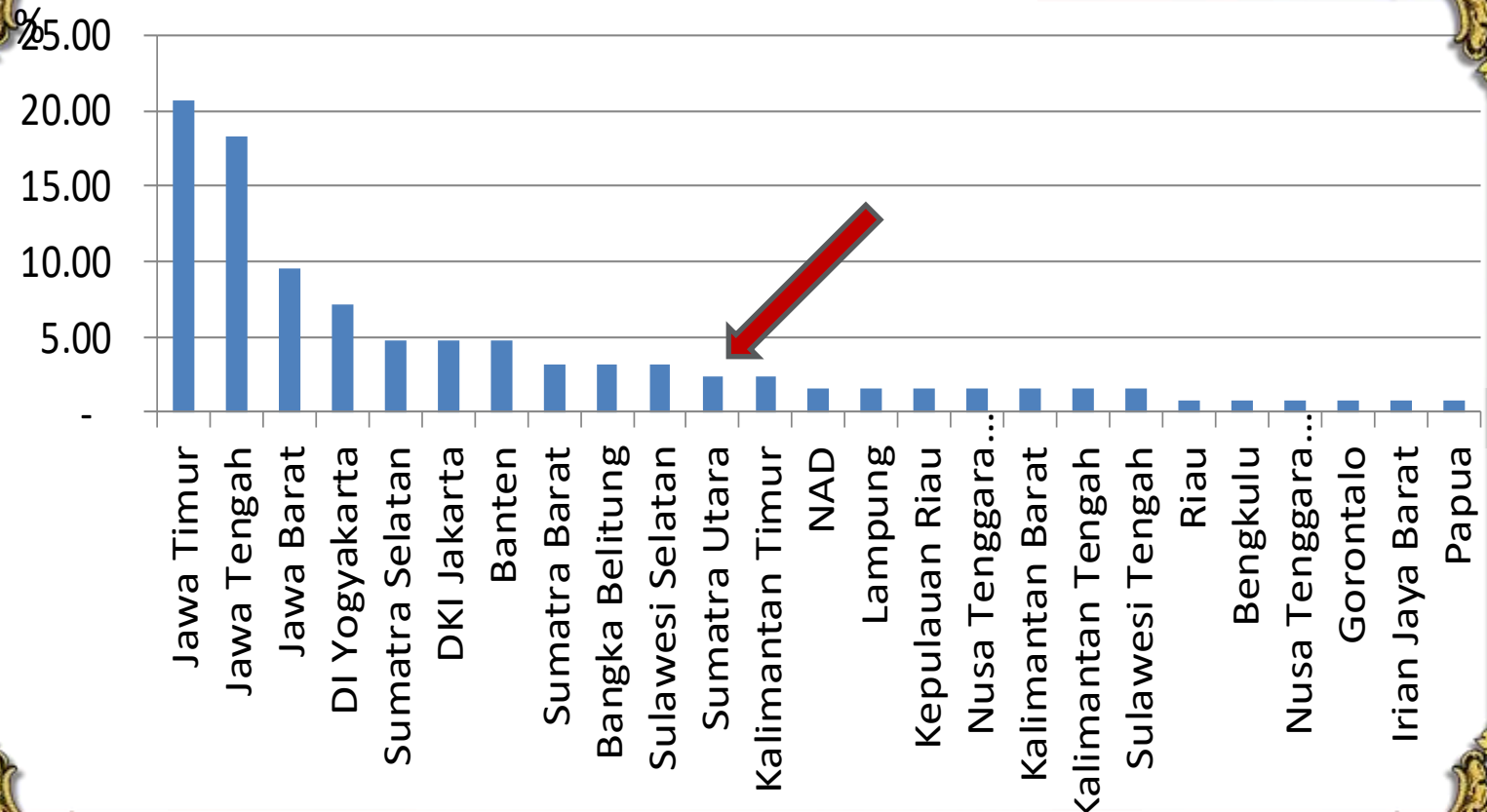
- ✓ Fasyankes,
- ✓ Tempat proses belajar mengajar,
- ✓ Tempat anak bermain,
- ✓ Tempat ibadah,
- ✓ Angkutan umum,
- ✓ Tempat kerja
- ✓ Tempat umum atau tempat lain yang ditentukan

Daerah yang telah memiliki kebijakan KTR Di Indonesia



- Saat ini sudah ada 23 propinsi di mana didalamnya terdapat 58 Kab/Kota yang memiliki perda/pergub/perwali/perbub/surat edaran tentang kebijakan KTR

USIA MULAI MEROKOK (5 TAHUN) BERDASARKAN PROVINSI



Riskesdas, 2010

Regulasi Gula, Garam dan Lemak

Rancangan Permenkes Konsumsi Gula, Garam dan Lemak pada Pangan Olahan dan Siap saji

**BATAS MAKSIMUM
KONSUMSI GULA, GARAM
DAN LEMAK PERORANG
PERHARI**



**Penguatan Labeling
Gula, Garam dan
Lemak (Pencantuman
Informasi Nilai Gizi)**

**Peringatan Kesehatan
pada Label Produk
Pangan Olahan dan
Siap saji**

**Penyajian Pangan Olahan dan Siap Saji, Adanya Menu
Penyeimbang (Buah dan Sayur Segar) dan Menyediakan
Produk Pangan Rendah Gula, Garam dan Lemak →**

Konsumen Memilih / Menentukan Sendiri

MARI MENUJU MASA MUDA SEHAT HARI TUA NIKMAT TANPA PTM DENGAN PERILAKU CERDIK

C

Cek kondisi kesehatan secara rutin dan teratur

E

Enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya

R

Rajin Aktifitas fisik dengan gerak olah raga dan seni

D

Diet yang sehat dengan kalori seimbang (rendah gula, garam dan lemak serta kaya serat)

I

Istirahat yang cukup

K

Kendalikan stres



KESIMPULAN

Masalah PTM meningkat dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia

Fokus Pengendalian: Faktor risiko, deteksi dini & tindak lanjut dini mulai dari “masyarakat” (POS BINDU) dan Saryankes dasar Puskesmas

Pelaksanaan: Multidisiplin, Lintas Sektor dan Lintas program : Pemerintah, Profesi, PT, dan Swasta melalui jejaring Pengendalian PTM



RENCANA AKSI

- **ADVOKASI** kebijakan pengendalian PTM:
Pengembangan program & dukungan anggaran
- **Peningkatan kapasitas SDM:**
Akhir 2013 semua prov punya tim pelatih PTM
- **Penguatan jejaring kerja & kemitraan →**
Pembentukan Pokja PPTM dan KTR di tk Pusat, Prov, Kab/Kot:
Akhir 2014 semua Prov memiliki kebijakan KTR
- **Deteksi Dini & TL Dini PTM & FR di masyarakat dgn menyelenggarakan Posbindu PTM**
- **Peningkatan akses pelayanan dan penguatan pelayanan PTM di faskes dasar (Puskesmas, Dokter keluarga, praktik kesehatan)**
- **Pengembangan sistem surveilans dan registri PTM**



Terima Kasih

